Сеченовский Университет

Институт аналитической токсикологии

МетаboСкан

МЕТАБОСКАН · MS(P)-001-T0 · РАПОРТ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Ваш метаболомный профиль плазмы крови

Что показал анализ, что это значит для вас и что делать дальше

Плазма крови · точка T0 · пациентская версия

Пациент-2 Код образца: J0SJF9

ВОЗРАСТ / ПОЛ	ДАТА ЗАБОРА КРОВИ	ОТЧЁТ СФОРМИРОВАН
64 · M	16.10.2026	23.10.2026

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД ПО ПРОФИЛЮ

MHI · ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Выраженное напряжение резервов

3,5/10

TMAO и его источники. TMAO Z +3,05. Версии: недавняя рыба/морепродукты, другие пищевые источники или особенности почечного выведения. **Как проверить:** Сверить рацион перед T0 и креатинин/СКФ; один TMAO не позволяет выбрать источник.

Зоны внимания

01 / ФОКУС
Энергетика клеток

02 / ФОКУС
Сосуды и микроциркуляция

03 / ФОКУС
Обезвреживание и метилирование

Как пользоваться этим отчётом

1 **Прочитайте страницы 2–3**
что показал анализ и что это значит для вашей повседневной жизни.

2 **Посмотрите главные зоны внимания**
страницы 9–10: что мы увидели, что это может значить и что делать.

3 **Начните план на 4–6 недель**
страница 11 — два-три пункта, которые проще всего встроить в жизнь.

4 **Запишитесь на первый приём**
врач первого шага: терапевт; список анализов и вопросов на странице 12.

МетабоСкан не ставит диагноз: он оценивает функциональное состояние организма у здорового человека или на фоне заболевания и/или терапии. Выводы обсудите с врачом.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДЕ · КАК ЧИТАТЬ ОТЧЁТ

О МетабоСкан

Что такое этот анализ и что он вам даёт

Плазма крови → Профиль обмена → Приоритеты для врача → Динамика

Метаболом — это набор малых молекул в крови: аминокислоты, продукты обмена жиров, витамины, сигнальные вещества. Их уровни дополняют обычные анализы и клиническую картину, но не позволяют сами по себе предсказать болезнь. Метаболомный профиль помогает увидеть, какие обменные системы стоит обсудить с врачом и проверить в динамике.

Биохимический сигнал

Профиль выделяет сдвиги в этой пробе. Они помогают сформулировать вопросы врачу, но не позволяют предсказать болезнь или назвать её причину.

Понятные приоритеты

Из всех измеренных показателей отчёт выделяет две-три главные зоны внимания и объясняет, почему именно они. Не нужно разбираться в каждом веществе.

Конкретный маршрут

Вы узнаете, к какому врачу идти в первую очередь, какие обычные анализы попросить и какие вопросы задать, чтобы визит был полезным.

Точка отсчёта

Повтор при сопоставимых условиях покажет, изменились ли показатели. Пользу для здоровья врач оценивает отдельно — по самочувствию и обычным клиническим данным.

Чего этот анализ не делает

- Не ставит диагноз. Отклонение показателя — это сигнал для проверки, а не болезнь.
- Не заменяет обычные анализы и осмотр врача — он подсказывает, что именно стоит проверить.
- Не назначает лечение и добавки. Всё, что описано в отчёте как «обсудить с врачом», требует очной консультации.

Цифры вашей пробы

Индивидуальные результаты — в следующих разделах

154	30	27
показателя в профиле	с выраженным сдвигом по Z (|Z| ≥ 2)	вне литературного интервала

97 измерено напрямую · 57 — расчётные показатели. Каждый показатель входит в подсчёт один раз (повторы объединяются). Само по себе количество сдвигов не устанавливает болезнь. Решение о диагнозе и лечении принимает врач с учётом жалоб и обычных анализов.

Ваш контекст учтён. В отчёте учтены указанные вами заболевания: часть сигналов может быть связана с ними. Этот контекст учтён в персональных выводах и маршруте к врачу.

Короткий словарь

Метаболом
совокупность малых молекул (продуктов обмена веществ) в крови.

Референсный диапазон и Z-оценка
референс — коридор значений здоровых людей, выход за него — сигнал, а не диагноз. Z-оценка показывает, на сколько значение отличается от здоровой группы сравнения: |Z| ≥ 2 — выраженный сдвиг; границы у референса и Z разные.

Шкала 0–10
единая шкала оценок в отчёте: чем выше, тем лучше состояние системы.

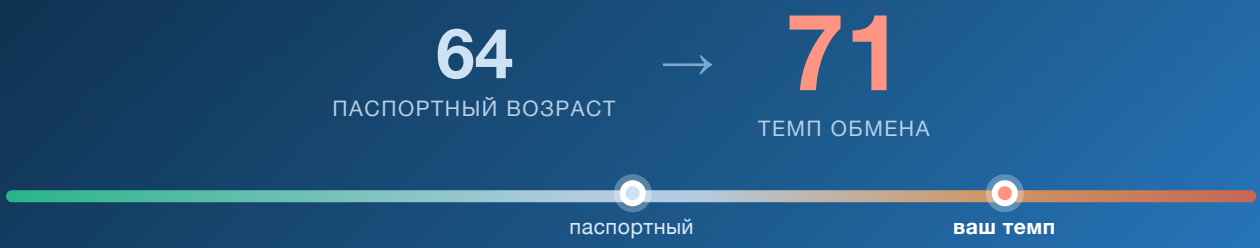
Митохондрии
«энергостанции» клеток, где жиры и сахара превращаются в энергию.

Микроциркуляция
кровоток в самых мелких сосудах, через которые ткани получают кислород.

Триптофан → серотонин / кинуренин
аминокислота, из которой организм делает либо серотонин и мелатонин, либо продукты «воспалительного» пути.

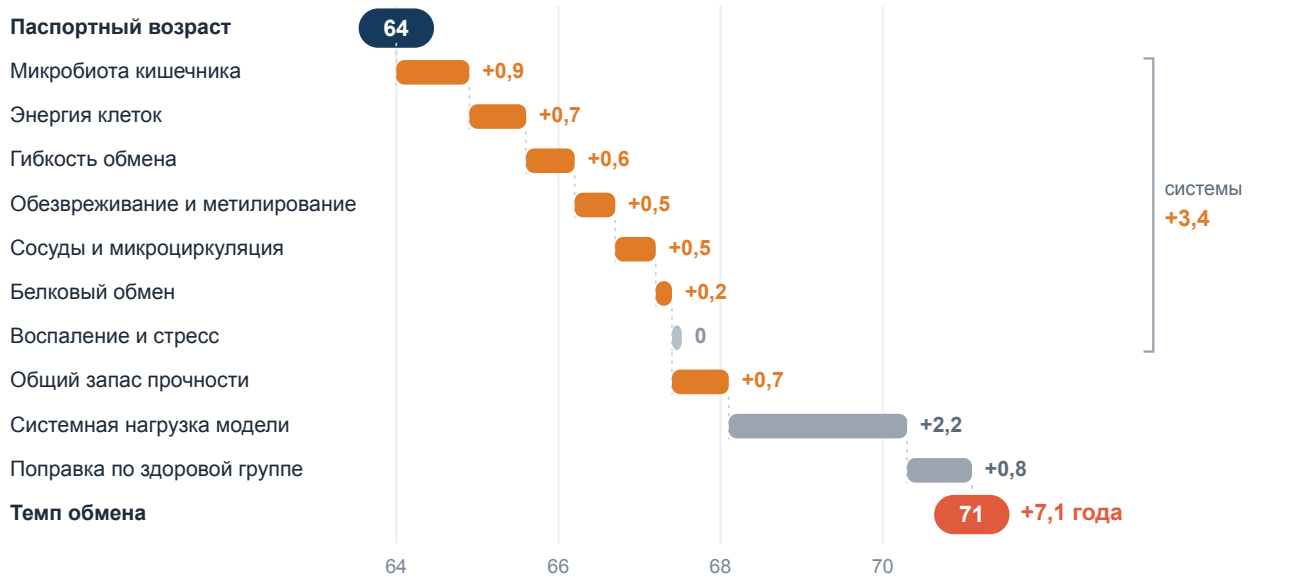
Темп метаболического старения

Это не биологический возраст по ДНК и не диагноз, а темп, с которым обмен расходует запас прочности. Он считается по тем же показателям, что и остальной отчёт, и большая часть его обратима.



Обмен работает как у человека 71 года — на 7,1 года больше паспортного возраста. Это оценка темпа, а не утверждение, что организм буквально стал старше.

ВКЛАД В ТЕМП, ЛЕТ



ГЛАВНЫЕ РЫЧАГИ

+0,9 Поработать с питанием кишечника
больше клетчатки и разнообразия, меньше алкоголя и ультраобработанной еды

+0,7 Поддержать энергетический обмен
регулярное движение и достаточный сон; резкие голодания не помогают

ОБРАТИМОСТЬ

Сдвиги обратимы, но не мгновенно: на заметное изменение темпа нужны месяцы. Первый контроль через 4–6 недель покажет направление, а не итог. Полнота данных панели высокая: оценены все системы.

Первый контроль: через 4–6 недель после начала изменений, или по рекомендации врача

Как это считается. Разница складывается из вкладов систем, резерва, системной нагрузки и калибровки по здоровой группе. Остаток показан отдельно. Это модельная оценка, не биологический возраст. В возрастной группе 60-70 лет n=2; возрастная калибровка недоступна. Поправка рассчитана по полу.

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОМ КОНТИНУУМЕ

Траектория организма

Континуум описывает не болезнь, а способ поддержания равновесия. Точка T0 — где организм сейчас; стрелки — направления, а не предсказание.

Шкала траектории: Класс 0 + 5 классов профиля = 6 зон. Сейчас — Класс 4 · множественные выраженные отклонения (5-я зона из 6). Это не номер фазы MHI (от 1 до 5): обе шкалы используют данные общего профиля, но имеют разные границы и задачи.



ЧТЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ

Организм — Класс 4 · множественные выраженные отклонения. Сводный индекс контуров плазмы — 3,5/10 (выраженное напряжение); ведущий контур — энергетика клеток 2,0/10. Это точка отсчёта для следующего измерения (T0→T1→T2), а не предсказание будущего.

ЧТО ПОКАЖЕТ СЛЕДУЮЩАЯ ТОЧКА

Что будет дальше, по одной точке не определяется. Направление динамики покажет повторное измерение через 4–6 недель. Наблюдают за нагрузкой по ведущему контуру: именно её изменение видно между точками.

Ваш общий результат



ОБЩАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОБМЕНА

Выраженное напряжение резервов

В этой пробе по измеренным Z-сдвигам одновременно выделяются tmao и его источники. На обложке указаны версии причин и проверки; следующие страницы показывают сами показатели и их клинический контекст.

Фаза 4 из 5 0–10 · выше — лучше

ЗОНА ВНИМАНИЯ

Переносимость нагрузки · 2,2 / 10

существенно снижен

НАИБОЛЬШИЙ РЕСУРС ПРОФИЛЯ

Скорость восстановления · 6,4 / 10

умеренное напряжение

Пять сторон вашего обмена

Ресурс · восстановление · нагрузка

ARI

Запас на восстановление



выраженное напряжение

Запас снижен: после перегрузки восстановление идёт медленно. Сейчас важно не накапливать усталость.

LTI

Переносимость нагрузки



существенно снижен

Переносимость снижена: избегайте резких пиков нагрузки, увеличивайте её постепенно.

RSI

Скорость восстановления



умеренное напряжение

Восстановление идёт, но медленнее нормы: следите за сном и днями отдыха.

IME



Экономичность обмена

выраженное напряжение

Стабильность обходится дорого: организм тратит много ресурсов на обычные задачи. Это одна из причин усталости.

ORI



Устойчивость к перегрузке

высокая уязвимость

Устойчивость к перегрузке снижена: сейчас не время для резких стартов — новых интенсивных тренировок, жёстких диет, авралов без отдыха.

Общий индекс MHI — отдельный интегральный показатель из исходных данных панели, а не среднее пяти оценок. Он может быть ниже каждой из них; карточки не следует складывать или усреднять.

ВАШ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ

Карта систем организма

Где сосредоточено внимание и что сохраняет ресурс.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ



Не анатомическая диагностика

ЗОНЫ ВНИМАНИЯ

Энергетика клеток
существенно снижен
2,0 /10

Сосуды и микроциркуляция
выраженное напряжение
3,2 /10

Обезвреживание и метилирование
выраженное напряжение
4,2 /10

Микробиота кишечника
выраженное напряжение
4,4 /10

Белковый обмен
умеренное напряжение
5,6 /10

СОХРАНЁННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Иммунная и стрессовая нагрузка
высокий резерв
10,0 /10

Оценка 0–10: **выше — больше функциональный резерв.** Статусы рассчитаны для текущей пробы.

Органные контуры

Отдельные оценки модели

Сердце и сосуды
5,0 /10
умеренное напряжение

Печень
5,0 /10
выраженное напряжение
Печень вовлечена в обменную нагрузку — проверьте печёночные пробы.

Дыхательная система
5,0 /10
умеренное напряжение

Иммунный баланс
6,0 /10
умеренное напряжение

Эти оценки описывают функциональный профиль на фоне здоровья, заболевания и/или терапии. Они не устанавливают диагноз и не показывают место повреждения органа.

Отчёт носит информационный характер и отражает функциональное состояние организма по метаболомному профилю. Он не является диагнозом и не заменяет консультацию врача. Все решения о лечении принимает ваш лечащий врач.

Магистрали обмена — простыми словами

«Магистрали» — это крупные пути обмена веществ. По одной точке крови мы видим, где движение изменено, но не можем назвать причину. Для каждого пути ниже: что именно видно, как это читается, чего анализ не доказывает и что с этим знанием делать.

затор — движение по пути заметно изменено; **уплотнение** — изменено умеренно; это плотность движения по маркерам, а не «поломка» фермента. Метка отражает согласованность сигнала по пути, а не величину одного маркера. В H8 высокий Z отдельного маркера не означает «затор» всей магистрали.

H2 · Аргинин → NO

уплотнение | связанный набор маркеров

Где смотреть. Эта карточка — разбор H2; схему H2 ищите по коду в приложении «Магистрали» врачебной версии.

Что видно. Лизин выше относительно здоровой группы; аргинин ниже относительно здоровой группы.

Как это читается. Доступность «сосудистой» аминокислоты аргинина сейчас ниже обычной. Такой рисунок бывает при нагрузке на сосудистую регуляцию, но её источник анализ не показывает.

Что это не доказывает. Это не диагноз болезни сосудов и не измерение их состояния.

Что делать с этим знанием. Сверить давление и обычные анализы (липиды, почки) у врача.

H8 · BCAA → энергия

уплотнение | сдвиги без локализации

Где смотреть. Эта карточка — разбор H8; схему H8 ищите по коду в приложении «Магистрали» врачебной версии.

Что видно. Лейцин + изолейцин, сумма изомеров C5, глутамат выше относительно здоровой группы.

Как это читается. Аминокислоты с разветвлённой цепью сдвинуты как общий пул — чаще из-за питания и обмена.

Что это не доказывает. Это не болезнь мышц и не дефицит витаминов.

Что делать с этим знанием. Отметить характер питания перед забором; отдельных действий не требуется.

Код H1, H2 и т. д. — адрес магистрали: по нему её можно найти в приложении «Магистрали» врачебной версии и в рапорте для специалистов. Здесь приведено объяснение именно того, что показано в вашей пробе.

Магистрали обмена — продолжение

Ещё пути, в которых именно в этой пробе есть заметные сдвиги.

H11 · Метилирование

затор · сдвиги без локализации

Где смотреть. Эта карточка — разбор H11; схему H11 ищите по коду в приложении «Магистрали» врачебной версии.

Что видно. Таурин, холин, диметилглицин выше относительно здоровой группы.

Как это читается. Один из показателей «метильного» контура сдвинут — такое бывает при особенностях питания и работе печени.

Что это не доказывает. Это не доказательство дефицита витаминов группы B.

Что делать с этим знанием. При случае проверить B12 и фолат у врача; заранее ничего не принимать.

H9 · Карнитин и β-окисление

затор · сдвиги без локализации

Где смотреть. Эта карточка — разбор H9; схему H9 ищите по коду в приложении «Магистрали» врачебной версии.

Что видно. СДК: C14–C18, лизин выше относительно здоровой группы.

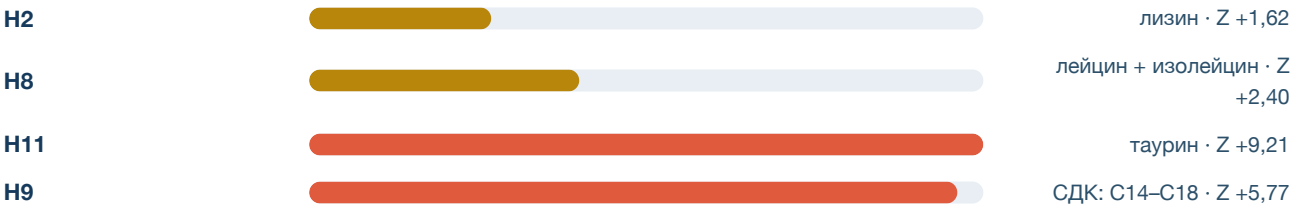
Как это читается. Уровень карнитина в крови зависит от питания и работы почек.

Что это не доказывает. Это не означает нехватку карнитина в мышцах.

Что делать с этим знанием. Без добавок; при вопросах — обсудить рацион с врачом.

Показанные пути — измеренные ориентиры

Для каждого пути показан один измеренный маркер с наибольшим |Z|, а не активность фермента или диагноз. Длина полосы — величина |Z| (шкала до 6); числа выше 6 показаны полностью.



Всего 19 путей: 9 с заметными сдвигами (здесь разобраны H2, H8, H11, H9) и 10 без согласованного сигнала; остальные — в рапорте для специалистов.

Эти наблюдения — не диагнозы и не повод менять лечение или начинать добавки. Возьмите отчёт к врачу: он сопоставит их с самочувствием и обычными анализами.

Код H1, H2 и т. д. — адрес магистрали: по нему её можно найти в приложении «Магистрали» врачебной версии и в рапорте для специалистов. Здесь приведено объяснение именно того, что показано в вашей пробе.

Три главные зоны внимания

Здесь собраны зоны с наиболее заметными сигналами модели. Для каждой показаны измеренные маркеры, проверяемые версии и следующий шаг; сам индекс не устанавливает причину изменений.

1. Энергетика клеток

существенно снижен **2,0** / 10

Как распределены в этой пробе карнитин и связанные с ним продукты обмена жиров и аминокислот.

В пробе выделяются некоторые ацилкарнитины. На их уровни влияют питание, голодание, недавняя нагрузка и заболевания. По ним нельзя напрямую измерить производство энергии или установить причину усталости.

ЧТО МЫ УВИДЕЛИ В КРОВИ

- **линолеоилкарнитин (C18-2) (Z +4,97)** — выше относительно здоровой группы
- **соотношение аминокислот с разветвлённой цепью к ароматическим (Z +2,65)** — на верхней границе: признак интенсивного мышечного обмена
- **длинноцепочечные ацилкарнитины — расчётный сигнал модели: лимитирующий (не измерение)** — их распределение изменено; скорость окисления жиров не измерена
- **ацилкарнитиновый баланс — расчётный сигнал модели: лимитирующий (не измерение)** — баланс фракций не позволяет определить полноту окисления жиров

ЧТО ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС

- Сообщите врачу, когда ели и тренировались перед забором, принимали ли карнитин.
- Сверьте с врачом глюкозу натощак, HbA1c и липиды: они помогут оценить углеводный фон.
- При повторе сдавайте пробу в сопоставимых условиях; не начинайте карнитин по одному профилю.

> **Чем это не является.** Это не диагноз болезни митохондрий и не доказательство того, что жиры «сжигаются не до конца». Причину оценивают по клинической картине и обычным анализам.

2. Сосуды и микроциркуляция

выраженное напряжение **3,2** / 10

Насколько свободно кровь доставляет кислород и питание к тканям, и как почки выводят продукты обмена.

Профиль похож на картину, при которой сосудам труднее расслабляться: в крови выше вещества, мешающие сосудистой регуляции, и ниже баланс защитных факторов. Это возможный паттерн, а не установленное нарушение сосудов. Это может проявляться как усталость, плохая переносимость нагрузки, головные боли, отёки, колебания давления — но может и никак не проявляться.

ЧТО МЫ УВИДЕЛИ В КРОВИ

- **баланс «аргинин / ADMA» — защитный резерв сосудов (Z –2,19)** — снижен: защитных факторов для сосудов меньше, чем нужно
- **доступность оксида азота (NO) — расчётный сигнал модели: лимитирующий (не измерение)** — сосудам не хватает «расслабляющего» сигнала

ЧТО ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС

- Измеряйте артериальное давление и пульс дома 7 дней подряд утром и вечером, записывайте — возьмите дневник к врачу.
- Пейте воду равномерно в течение дня (ориентир — 30 мл на кг веса, если врач не ограничил жидкость); не досаливайте еду.
- Ходьба 30–40 минут в день в комфортном темпе — лучшая «тренировка» для сосудов сейчас.

> **Чем это не является.** Это не диагноз «гипертония» или «болезнь почек». Это сигнал измерить давление и проверить почки обычными анализами.

Зоны внимания (продолжение)

3. Обезвреживание и метилирование

выраженное напряжение **4,2** / 10

Как в этой пробе распределены вещества метионин-холинового пути; функция печени и обеспеченность витаминами отдельно не измерены.

Профиль показывает напряжение некоторых путей обмена. Причину по этой панели установить нельзя: питание, лекарства, состояние печени и другие факторы врач оценит отдельно. Низкий индекс сам по себе не доказывает дефицит витаминов группы B.

ЧТО МЫ УВИДЕЛИ В КРОВИ

- **холин (Z +2,25)** — на верхней границе
- **диметилглицин (Z +2,10)** — выше относительно здоровой группы
- **метионин-холиновый паттерн — расчётный сигнал модели: лимитирующий (не измерение)** — сочетание метаболитов требует сопоставления; дефицит витаминов не установлен
- **использование витамина B5 — расчётный сигнал модели: лимитирующий (не измерение)** — не измеряет фактическое использование витамина B5

ЧТО ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС

- Вспомните рацион и добавки перед забором, особенно белок, холин, бетаин и витамины B.
- Уточните у врача, нужны ли гомоцистеин, B12 и фолат; по профилю дефицит не установлен.
- Если условия забора неясны, обсудите повтор в сопоставимых условиях.

> **Чем это не является.** Это не диагноз заболевания печени и не доказательство дефицита витаминов B. Стандартные анализы нужны при соответствующих клинических основаниях.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА

Ваш план на 4–6 недель

6 шагов под ваш профиль

Фокус периода — поддержать системы, выделенные в вашем профиле, и проверить причины сдвигов вместе с врачом. Начните с первых двух шагов; остальные добавляйте по мере сил.

1 **Старт** — Начните с двух шагов

2 **Регулярность** — Добавляйте постепенно

3 **Через 4–6 недель** — Динамика — с врачом

Ваши действия

Каждый пункт здесь выбран под ваш профиль: рядом написано, с чем он связан.

01 Без длинных перерывов без еды

Сохраняйте регулярный режим питания; не совмещайте длительное голодание с интенсивными нагрузками. Если пропуски еды связаны с плохим аппетитом, обсудите это с врачом.

Почему: тема «Ацилкарнитины и условия забора» — отмечено в 5 разделах модели

02 Нагрузка без пиков

Начните с посильной спокойной ходьбы без рывков; общий недельный объём согласуйте с врачом или тренером и не добавляйте ходьбу поверх уже назначенного плана. Ориентир — восстановление к следующему дню, а не усталость.

Почему: тема «Ацилкарнитины и условия забора»

03 Клетчатка и регулярность стула

Овощи, зелень и цельные крупы ежедневно; отмечайте регулярность и комфорт стула. Бактериям кишечника нужна не добавка, а еда.

Почему: тема «Микробиота, питание и почки» — отмечено в 4 разделах модели

04 Пищевой дневник за 2–3 дня до повтора

Перед повторным анализом запишите рыбу, морепродукты, красное мясо, яйца и добавки. Без этого часть показателей нельзя правильно прочитать.

Почему: тема «Микробиота, питание и почки»

05 Снять нагрузку на переработку

Минимум алкоголя, отказ от случайных добавок и обезболивающих без назначения; список всех препаратов — врачу.

Почему: тема «Метионин-холиновый путь» — отмечено в 4 разделах модели

06 Питьевой режим и контроль давления

Пейте воду равномерно в течение дня, ограничьте досаливание и готовые продукты. Неделю измеряйте давление и пульс утром и вечером — записи возьмите к врачу.

Почему: зона внимания «Сосуды и микроциркуляция» — 3,2 / 10

Что уже работает — не теряйте

Иммунная и стрессовая нагрузка **10,0 / 10 · высокий резерв**

Поддерживайте эти системы привычным режимом; специально «лечить» их не нужно.

К приёму и повторному анализу

- ☐ Вести 7 дней обычный дневник еды и алкоголя, ничего не меняя специально
- ☐ Измерять давление и пульс утром и вечером 7 дней, записывать в таблицу
- ☐ 7 дней отмечать стул, вздутие и боли в животе
- ☐ Умеренная физическая активность разрешена: код диагноза сам по себе её не запрещает
- ☐ Тренировки: спокойная аэробная работа и техника без отказа
- ☐ Повторный забор: натощак 8–12 часов

Это шаги, которые можно делать самому. Решения о препаратах и добавках принимает врач.

О добавках. Не начинайте новые добавки и не меняйте препараты по этому плану. Подбор и дозы — с врачом, с учётом заболеваний и текущей терапии. Принесите список всего, что принимаете.

К кому обратиться и что взять с собой

Шаг 1 — Терапевт (врач общей практики)	Первый визит — к терапевту: он оценит жалобы, назначит базовые анализы из списка ниже и решит, нужны ли узкие специалисты.
Эндокринолог	По результатам первичной оценки: энергетика клеток
Гастроэнтеролог	По результатам первичной оценки: обезвреживание и метилирование
Кардиолог	По результатам первичной оценки: сосуды и микроциркуляция

Какие анализы попросить

Это обычные, доступные анализы — они подтверждают или снимают сигналы метаболомного профиля. Окончательный список определяет врач.

- [ ] глюкоза натощак и гликированный гемоглобин (HbA1c)
- [ ] липидный профиль
- [ ] ТТГ (щитовидная железа)
- [ ] креатинин крови и расчёт СКФ
- [ ] общий анализ мочи
- [ ] альбумин/креатинин мочи (по решению врача)
- [ ] ЭКГ
- [ ] АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТ, билирубин
- [ ] витамин B12 и фолиевая кислота
- [ ] гомоцистеин (по решению врача)
- [ ] СРБ (вчСРБ) — воспалительный фон

Вопросы, которые стоит задать врачу

1. Что в моём случае может стоять за сигналом «энергетика клеток» (2,0 / 10) и как это проверить?
2. Что в моём случае может стоять за сигналом «сосуды и микроциркуляция» (3,2 / 10) и как это проверить?
3. Какие из отклонений в моём профиле требуют проверки в первую очередь?
4. Какие обычные анализы и обследования нужно сделать, чтобы подтвердить или исключить причины?
5. Есть ли у меня заболевания или лекарства, которые могут объяснить эту картину?
6. Какой уровень физической нагрузки мне сейчас безопасен?
7. Нужны ли мне добавки, и какие из них противопоказаны при моей терапии?
8. Когда повторить метаболомный анализ, чтобы оценить динамику?

Что взять с собой

- [ ] Этот отчёт и отчёт для врача (полная версия MS(P)-001-T0)
- [ ] Дневник давления и пульса за 7 дней
- [ ] Список всех лекарств и добавок, которые вы принимаете
- [ ] Результаты анализов за последний год, если есть

Когда обращаться к врачу не откладывая

- боль или давление в груди, особенно при нагрузке
- одышка в покое или при обычной ходьбе, отёки ног
- артериальное давление стабильно выше 160/100 или ниже 90/60 с плохим самочувствием
- обмороки, сильное головокружение, нарушения ритма сердца
- резкая слабость, потеря веса без причины, температура без объяснения

Сведения из вашей анкеты

Записи сохранены для сверки. Выбор пункта с перечнем симптомов не подтверждает каждый из них. Заболевания и актуальный приём препаратов уточните с врачом.

Выбранные пункты анкеты: жалобы

В анкете не указано

Заболевания, сообщённые в анкете

K81.8

Препараты и БАДы: ваша запись

В анкете не указано

Рост

В анкете не указано

Вес

В анкете не указано

Физическая активность

В анкете не указано